3.1.4 영양관리			
규 정 번 호	3.1.4	제 정 일	
관 련 인증기준	3.1.4 영양관리	최근 개정일	
담 당 부 서	영양팀	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	「의료법 시행규칙」 제38조, 제39조 및 〔별표6〕 의료기관의 급식관리 기준		

▣ 목적 (Purpose)

의료기관은 환자에게 적합한 영양공급을 통해 치료 효과를 높일 수 있도록 영양평가를 시행하여 필요한 영양을 공급하며, 치료식이 필요한 경우 치료식의 내용과 이유를 충분히 설명하고 환자에게 필요한 영양 상담을 제공하여야 한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

· **치료식(Treatment Diets)** : 질병 치료를 위해 식품의 종류, 영양소 성분, 조리방법 등을 조절한 입원 환자 식사로 당뇨식, 저염식, 연하 보조식으로 구분된다.

· **밀 라운딩 (Meal Rounding)** : 배식 시 환자의 식사 섭취 상태를 파악하기 위하여 영양사가 병동을 순회하는 것을 의미한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 영양관리에 대한 규정이 있다.
2. 환자의 치료 목적에 맞게 식사를 제공한다.
3. 환자에게 치료식에 대해 설명한다.
4. 환자에게 영양상담을 제공한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 식사처방 지침

가. 식사처방지침은 병원에서 제공되는 식사의 특징, 영양기준량, 식품구성 등으로 구성되어 있으며, 영양관리위원회 심의·승인을 거쳐 적용한다.

나. 식사처방지침에는 치료식 식단작성지침, 임상영양관리지침 등의 내용을 포함한다.

다. 치료식 식단작성지침은 식사처방지침에 제시된 영양기준과 식사구성에 따른 식단을 작성하기 위한 방법과 권장(허용)식품 및 주의(제한)식품 등으로 구성되어 있으며, 영양관리위원회 심의·승인을 거친다.

라. 임상영양관리지침은 환자의 영양 상태 평가 및 임상적 필요에 따른 영양 중재 기준을 마련하여 운용한다.

2. 식사처방 및 제공

가. 의사는 환자의 영양적 필요와 치료계획을 기반으로 식사처방지침에 따라 처방한다.

나. 식이의 구분과 종류를 입력하고 특이사항이 있는 경우에는 코멘트에 입력하도록 한다.
다. 환자의 상태 및 치료 계획에 따라 기존 식이 종류만으로 적절한 식사 제공이 어려운 경우 영양팀과 협의 후 환자에게 필요한 식사 처방을 입력한다.
라. 영양사는 밀 라운딩(Meal Rounding)을 통하여 환자의 식사 섭취율 및 식사 관련 특이사항 정보를 수집하고, 이에 따라 식사 처방의 변경 또는 추가 코멘트가 필요한 경우 해당 담당 의사에게 식사 변경에 대한 의견을 제시할 수 있다
마. 환자식 배식 시 환자의 식사명과 특이사항을 확인 후 배식한다.
바. 입원환자에 대한 식사 배식시간은 병동의 투약 및 간호업무 등을 고려하여 다음과 같이 운영한다.

구분	배식시간
조식	06:40 ~ 07:00
중식	11:40 ~ 12:00
석식	16:40 ~ 17:00

3. 치료식처방 및 제공

가. 치료식은 환자의 상태와 치료 목적을 고려하여 식사처방지침에 따라 담당 의사가 처방한다.
나. 영양사는 치료식 식단작성지침에 근거, 치료식에 대한 식단을 작성한다.
다. 영양사는 매끼 병실별 환자 현황 및 치료식 환자 현황을 확인 후 음식의 조리 상태가 적합한가를 확인한다.
라. 병원에서 제공하는 치료식은 다음과 같다.
1) 당뇨식
2) 저염식
3) 연하보조식

4. 치료식 설명

가. 치료식이 처음 처방된 환자 또는 보호자, 간병인에게 영양사가 환자의 영양관리를 통한 치료효과를 높일 수 있도록 치료식의 종류, 제공 사유, 주의사항(음식 제한사항 등)에 대해 설명하고 치료식 안내문을 제공한다.
나. 치료식 설명은 치료식 첫 끼니를 기준으로 24시간 이내에 제공한다. 단, 공휴일 및 휴일은 제외한다.
다. 치료식 첫 끼니 이후 검사, 시술, 외출 등의 사유로 2끼니 이상 금식이 지속되는 경우에는 치료식 설명을 시행하지 않으며, 금식 종료 후 치료식이 다시 시작되는 첫 끼니를 기준으로 48시간 이내에 치료식 설명을 제공한다.
라. 영양사는 매일 시행하는 치료식 밀라운딩 및 설명 내용을 당일 출력한 치료식 환자 명단에 작성하여, 월별 바인더에 편철하여 증빙 자료로 보관·관리한다.

5. 영양상담

가. 영양검색 및 선별

1) 영양관리가 필요한 환자를 선별하기 위하여 입원 72시간 이내(주말 및 공휴일의 경우 해당 일수만큼 더하여 산정)에 영양초기평가에 필요한 정보(환자의 키, 몸무게, 체중감소, 삼킴 장애 등)를 수집한다.
2) 영양초기평가에 필요한 객관적인 정보들의 수집이 72시간 이내에 이루어지지 않으면 미룰 수 있다.

나. 영양상담 의뢰기준

1) 영양초기평가에서 영양상태가 불량 또는 심한불량으로 평가된 환자 중 주치의로부터 영양상담이 의뢰된 경우
2) 영양상태의 재평가가 필요하다고 생각되는 환자 중 주치의로부터 영양상담이 의뢰 된 경우

다. 영양상담 중재 및 기록

1) 영양초기평가에서 영양상태가 불량 또는 심한불량으로 평가된 환자는 영양사가 주치의에게 보고하고 그 결과에 따라 주치의는 영양상담을 요청할 수 있다.
2) 영양상태의 재평가가 필요하다고 생각되는 재원환자는 주치의가 영양상담을 의뢰하고, 영양사는 영양상담을 시행한 후 영양상담일지를 작성한다.
3) 영양상담을 통해 환자의 객관적 평가, 식사정보(식욕, 알레르기를 포함한 식사 시 문제점 등)를 파악하여 영양치료에 대한 계획을 수립하고 필요에 따라 식이 조정을 제언하거나 식이 교육 등을 실시한다.
4) 작성된 영양상담일지는 전자의무기록(EMR)을 통해 담당의사와 공유한다.

▣ 부록

1. 치료식 식사 안내문
   -당뇨식
   -저염식
   -연하보조식
2. 영양초기평가
3 영양상담 의뢰서 및 회신서
4. 영양상담일지
5. 식이처방지침서
   - 치료식식단작성지침
   - 임상영양관리지침

▣ 규정 개정일 [누적]

부록1. 치료식 식사(당뇨식) 안내문

치료식 식사 안내문(당뇨식)

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

1. 치료식명: 당뇨식

2. 제공사유

당뇨식은 혈당 및 혈중 지질대사의 정상화, 표준체중 유지, 합병증 예방 및 적잘한 영양 상태 유지를 목적으로 합니다.

3. 주의사항

	1. 매일 일정한 시간에, 알맞은 양의 음식을 규칙적으로 섭취합니다. ☞ 적절한 열량섭취와 규칙적인 식사는 혈당 조절에 도움이 됩니다
	2. 설탕, 꿀, 물엿 등 단순당의 섭취를 주의합니다. ☞ 단순당은 농축된 열량원이며, 소화흡수가 빨라 급격한 혈당 상승을 유발합니다.
	3. 채소류, 해조류 등 식이섬유소를 적절히 섭취합니다. ☞ 식이섬유소는 혈당과 혈중 지방 농도를 낮추어 혈당 조절 및 심혈관계 질환 예방에 도움이 됩니다.
	4. 지방은 적정량 섭취하되 콜레스테롤 섭취는 제한합니다. ☞ 동물성지방 및 콜레스테롤은 심혈관계 질환 위험을 높이므로 포화지방 섭취를 줄이고 식물성 기름을 적정량 사용합니다.
	5. 소금 섭취를 줄이고 싱겁게 먹는 습관을 가집니다. ☞ 과다한 소금 섭취는 혈압을 상승시킬 수 있으므로 가급게 싱겁게 조리하여 섭취합니다.

환자: (서명)

보호자: (서명)

환자와의 관계:

*보호자가 부득이하게 서명하게 될 경우, 반드시 대신 서명하게 된 사유에 대해 체크합니다.

☐ 환자의 신체적·정신적 장애로 인하여 내용에 대한 이해가 어려움

☐ 설명하는 것이 환자의 심신에 중대한 악영향을 미칠 것이 명백함

☐ 환자 본인이 승낙에 관한 권한을 특정인에 위임함

☐ 기타:

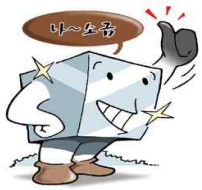
입원일자: 202 년 월 일

상담일자: 202 년 월 일

상담영양사: (서명)

치료식 식사 안내문(저염식)

1. 치료식명: 저염식



2. 제공사유

저염식은 치료목적으로 염분섭취를 제한하는 식사입니다.

3. 주의사항

〔일일 염분 섭취량 기준〕

1일 염분 섭취량을 5g으로 제한하는 경우, 식품 내 자연 염분(약2g)을 제외하면 실제로 사용하는 소금 양은 하루 3g(한 끼당 1g)으로 제한됩니다.

소금 1g에 해당하는 식품량(양념 및 식품별 비교)

식품명	무게(g)	눈대중량
소금	1g	0.5작은술
진간장	5g	1작은술
된장,고추장	10g	1/2큰술
토마토케찹	30g	2큰술
마요네즈	70g	5큰술
단무지	30g	6쪽
배추김치	30g	3쪽
명란젓	10g	-
마른멸치	40g	-

2. 향신료 및 신맛·단맛 활용: 식초 레몬, 오렌지즙, 겨자, 와사비, 후춧가루, 고추, 마늘, 생강, 양파, 카레가루 등을 적절히 사용하여 싱거운 맛에 변화를 줍니다.

3. 섭취 제한 식품: 젓갈, 장아찌, 김치, 자반생선, 햄, 라면 등 절인 식품 및 인스턴트 식품의 섭취를 제한합니다.

4. 국/찌개 섭취법: 국이나 찌개는 국물보다는 가급적 건더기 위주로 섭취합니다.

환자: (서명)

보호자: (서명)

환자와의 관계:

*보호자가 부득이하게 서명하게 될 경우, 반드시 대신 서명하게 된 사유에 대해 체크합니다.

☐ 환자의 신체적·정신적 장애로 인하여 내용에 대한 이해가 어려움

☐ 설명하는 것이 환자의 심신에 중대한 악영향을 미칠 것이 명백함

☐ 환자 본인이 승낙에 관한 권한을 특정인에 위임함

☐ 기타:

입원일자: 202 년 월 일

상담일자: 202 년 월 일

상담영양사: (서명)

치료식 식사 안내문(연하보조식)

1. 치료식명: 연하보조식

2. 제공사유

뇌졸중, 뇌혈관의 손상, 후두암, 뇌종양, 외과적 수술, 근이양증, 인후 또는 식도의 염증 및 협착 등으로 인해 음식을 씹고 삼키는 기능에 장애가 생긴 환자에 적용됩니다.

3. 식사 형태 및 점도 조절

· 환자의 적응도에 따라 미음, 죽, 다진죽, 갈축, 다진찬, 갈찬 중 선택하여 제공합니다.

· 액체 종류의 음식 섭취 시 필요에 따라 점도 증진제를 제공하며, 씹고 삼키는 능력에 맞춰 식사의 점도를 조절하고 진전시킵니다.

4. 식사 원칙

· **영양 불량 방지:** 불충분한 섭취로 인한 체중 감소, 비타민·무기질 결핍, 단백질-칼로리 영양불량 등의 문제가 발생하지 않도록 합니다.

· **경장 영양 고려:** 입으로 섭취하는 양이 불충분할 경우 경장 영양을 고려합니다.

· **다양한 식품 선택:** 특정 음식에 대한 싫증이나 과도한 의존을 방지하기 위해 다양한 식품을 선택합니다.

·**소량씩 자주 제공:** 환자가 한 번에 식사를 많이 하지 못하는 경우 소량씩 자주 제공합니다.

5. 주의사항

· **흡인 위험 방지:** 토하거나 기도 흡인의 위험을 줄일 수 있는 음식을 제공합니다.

· **상태 변화 반영:** 환자 상태에 변화가 생기면 이에 따라 식사를 재조정합니다.

· **식단 계획 및 다양성:** 적절한 체중과 영양 상태를 유지하도록 식단을 계획하고, 영양을 고려해 다양한 음식을 제공합니다.

· **자극적인 음식 제한:** 신맛이 강한 음식, 너무 뜨겁거나 차가운 음식 등 자극적인 음식은 제한합니다.

환자: (서명)

보호자: (서명)

환자와의 관계:

*보호자가 부득이하게 서명하게 될 경우, 반드시 대신 서명하게 된 사유에 대해 체크합니다.

☐ 환자의 신체적·정신적 장애로 인하여 내용에 대한 이해가 어려움

☐ 설명하는 것이 환자의 심신에 중대한 악영향을 미칠 것이 명백함

☐ 환자 본인이 승낙에 관한 권한을 특정인에 위임함

☐ 기타:

입원일자: 202 년 월 일

상담일자: 202 년 월 일

상담영양사: (서명)

부록2. 영양초기평가

영 양 초 기 평 가

등록번호		성 명	
생년월일		호 실	
입원일시		성별 / 나이	

항목	수치	영양불량정도		
		약간의(높음)	보통의(정상)	심한(낮음)
Albumin		5.4 이상	3.3 ~ 5.3	3.0 이하
Hb		15.0 이상	11.0 ~ 15.0	10.0 이하
BMI		23.1 ~	18.5 ~ 23.0	~ 18.4

임상정보 (보유병력)	□ 고혈압 □ 당뇨 □ 비만 □ 저혈압 □ 뇌경색 □ 치매 □ 폐질환 □ 신장질환 □ 변비
	□ 기타 :
신체상태	□저체중 □정상 □과체중 □비만 □부종/복수 □기타
	체중감소 여부 □무 □유(2점) (최근3개월이내)
식사형태	□일반식(0) □갈은식(2) □죽(2) □미음(2) □경관영양(2) □기타(2) ※기타 : 당뇨식, 저염식, 연하보조식 등 질환별 식이
식사 섭취 상태	□양호(⅔~1⅓ -0) □불량(⅓~⅔, 1⅓~⅔, -3) □심한불량(⅓이하, 1⅔이상, -5)

식사 시 문제점	저작상태	연하상태	건강상태
	□무엇이든 씹을 수 있다-0 □부드러운 것은 씹을 수 있다-1 □빠는 것이라면 가능하다-3 □씹을 수 없다/씹을 일이 없다-5	□무엇이든 삼킬 수 있다-0 □가끔 사래 들린다-1 □자주 심하게 사래 들린다-3 □삼킬 수 없다-5	□소화불량-2 □변비-2 □식욕저하-2 □치매-2 □우울증-2 □편식-2 □설사-2 □구토-2 □공복감-2 □불규칙한 식사-2 □해당사항 없음-0
	식품알레르기 : □무-0 □유( )-2 / 유당불내증 : □무-0 □유-2 식사속도 : □보통-0 □빠름-2 □느림-2		

영양 평가	1. 영양총평 ①총점 : 점 ②영양상태 : □양호(0~10) □불량(11~20) □심한불량(21~30) ※양호 : 건강 및 섭식, 영양 등에 문제가 없는 상태 불량 : 건강 및 섭식, 영양 등에 문제가 있어 세심한 관찰이 요구되는 상태(여윔, 비반, 부종 등) 심한불량 : 극도의 건강 및 섭식, 영양 등에 문제가 있어 의료적 처치가 필요한 상태 2. 영양권장량 · 기준체중 (□표준/□현재/□조정): kg, 에너지 kg · 활동도 : □ 가벼운 활동 □ 보통 활동 □ 심한 활동
영양 관리 계획	□불량, 심한 불량인 경우 의사에게 보고 □교육 자료 제공 □기타 영양사: (서명)

부록3. 영양상담 의뢰서 및 회신서

영양상담 의뢰서

등록번호			입 원 일		
환 자 명		성별/나이	/	병동/병실	/
신 장	cm	현재체중	kg	식 이 명	
진 단 명					
환자상태					
지시 영양사항					
진료과		담당의	인		

영양상담 회신서

식습관, 식생활력, 기호 및 운동, 휴양사활 등

영양소 섭취상황

식생활 및 영양평가

지도 내용

회 신 일	2026 년 09 월 09 일	영 양 사	최윤정 인

부록4. 영양상담일지

영양상담일지

등록번호 :		성명 :		성별/연령 :	

날짜		상담횟수		병실	309호
식사처방					

1. 신체계측							
키	cm	몸무게	kg	BMI		Albumin	
2. 영양공급형태							
섭취형태	□구강섭취 □경관섭취 □기타 ( )						
식사처방	□일반식 □일반연식 □치료식 □치료연식 □미음 □유동식						
찬의형태	□일반찬 □연하보조식(다진찬 , 갈찬)						
3. 식습관조사							
문제점	□식욕부진 □소화불량 □설사 □변비 □구토 □저작곤란 □체중과다 □과식 □불규칙한 식사시간 □불균형 된 식사 □식품 알레르기( ) □특이사항 없음 □기타 ( )						
4. 영양판정							
영양상태	□양호 □결핍예상 □결핍						

5. 영양상담	6. 영양교육

영양사 :

네이처요양병원